

Valoración inicial, plan terapéutico, seguimiento y egreso

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Integrar hallazgos y objetivos funcionales en un plan individualizado, medible y revisable.

2. Alcance y condiciones de uso

Intervención fisioterapéutica dentro de competencia y oferta. No presupone que toda derivación médica implica una técnica concreta o un número fijo de sesiones.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Fisioterapeuta responsable	Valorar, individualizar, informar, vigilar y registrar.
Ejecutor según proceso	Aplicar la técnica o tarea para la que tiene competencia.
Verificador o titular	Comprobar recursos, evidencias y acciones de mejora.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Obtener motivo, antecedentes, medicamentos relevantes, alergias, cirugías, restricciones,

Obtener motivo, antecedentes, medicamentos relevantes, alergias, cirugías, restricciones, contexto y metas. Verificar identidad, información disponible y consentimiento para valorar.

2. Buscar banderas rojas y deterioro: dolor torácico, disnea grave, déficit neurológico nuevo

Buscar banderas rojas y deterioro: dolor torácico, disnea grave, déficit neurológico nuevo o progresivo, sospecha de fractura, infección, trombosis o alteración esfinteriana nueva con signos neurológicos. Remitir según urgencia y no continuar pruebas provocativas inseguras.

3. Seleccionar examen funcional acorde con hipótesis: movimiento, fuerza, sensibilidad, balan

Seleccionar examen funcional acorde con hipótesis: movimiento, fuerza, sensibilidad, balance, marcha y medidas pertinentes. Registrar hallazgo, método y unidades, evitando copia automática de resultados previos.

4. Formular diagnóstico fisioterapéutico y objetivos acordados con línea base y tiempo de rev

Formular diagnóstico fisioterapéutico y objetivos acordados con línea base y tiempo de revisión. Definir intervención, frecuencia razonada, recursos, progresión y alternativas; justificar uso de agentes físicos por evidencia e indicación.

5. Antes de cada sesión reevaluar novedades y precauciones

Antes de cada sesión reevaluar novedades y precauciones. Documentar intervención y dosis real, respuesta, vigilancia, educación y conducta, incluyendo omisiones y modificaciones.

6. Reevaluar según evolución y plazo del plan

Reevaluar según evolución y plazo del plan. Egresar, prolongar, ajustar o remitir con razón documentada; entregar autocuidado, señales de alarma y continuidad y registrar metas alcanzadas o pendientes.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Registro cronológico de cada sesión.

Dosis individual y respuesta comprobables.

Egreso no se basa solo en terminar un paquete comercial.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.5 y 11.3.1.22-26: información documentada, prácticas seguras, recursos y formación. Limitar técnicas al portafolio y verificar condiciones reales.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Motivo y antecedentes	
Banderas rojas y conducta	
Hallazgos y medidas	
Diagnóstico fisioterapéutico	
Objetivos y línea base	
Plan y frecuencia	
Intervención parámetros y respuesta	
Educación	
Reevaluación y decisión	
Autor y autenticación	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Ejercicio profesional

Ley 528 de 1999, artículos 1-3 y 27, principios, competencias y consentimiento previo. El contenido exige evaluación integral y fundamento científico; no garantiza resultados ni amplía competencias por tener un formato.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66199>

Prácticas seguras

Resolución 3100, 11.1.5: política, actividades, instancia proporcional, identificación, comunicación, infección, eventos y consentimiento, documentación y formación; aplicar los criterios pertinentes al servicio.

<https://www.minsalud.gov.co/salud/prestacion-servicios/Paginas/sistema-obligatorio-garantia-calidad.aspx>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576